

Przodopochylenie miednicy

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Nauka ustawienia miednicy bliżej pozycji neutralnej, poprawa kontroli mięśni brzucha i pośladków oraz tolerancji wyprostu biodra.

Uwaga kliniczna
Samo przodopochylenie nie jest chorobą. Ćwiczymy wtedy, gdy to ustawienie wiąże się z bólem, przeciążeniem lub słabą kontrolą ruchu.

1 JOGA 1 Niski wykrok z podwinięciem miednicy

Z kłku wysuń jedną stopę do przodu. Delikatnie podwiń miednicę „ogon pod siebie”, napnij pośladek nogi zakrocznej i przesun tułów minimalnie do przodu. Nie rób przeprostu lędźwi.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2-3

Wskazówka: Rozciąganie powinno być z przodu biodra nogi zakrocznej.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka

Usiądź w kierunku pięt i wydłuż plecy, wyciągając ręce przed siebie. Oddychaj do dolnych żeber i rozluźnij odcinek lędźwiowy.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj pośladków na siłę do pięt.

3 POZIOM 1 - łatwy Tyłopochylenie miednicy w leżeniu

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Na wydechu delikatnie zbliż dolne żebra do miednicy i spłaszcz lędźwie do podłoża. Wróć do neutralnej pozycji bez odrywania stóp.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie

Wskazówka: Ruch ma pochodzić z miednicy, nie z mocnego napinania szyi.

4 POZIOM 2 - średni Most z kontrolą miednicy

Najpierw delikatnie ustaw miednicę neutralnie lub lekko podwiń, potem unieś biodra. Utrzymaj żebra „nad miednicą”, bez wypychania brzucha w górę.

Dawka: 8-12 powt. x 2-3

Wskazówka: Poczuj pośladki, nie tylko lędźwie.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył z kontrolą tułowia

Stań prosto, zrób krok w tył i zejdz w dół. Utrzymuj żebra nad miednicą, brzuch lekko aktywny i pośladek nogi podporowej napięty. Wróć do stania.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Nie pozwalaj, aby miednica uciekała w duży przeprost lędźwiowy.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.